

Дата: 01.02.2025

Полис ОМС: 2988299720000033

Медицинское учреждение : Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы"

Специализация: Врач-рентгенолог

ФИО: Савицкая Анна Николаевна

Магнитно-резонансная томография коленного сустава

Информация об исследовании	Предварительный диагноз: не указано Цель исследования: не указано Обоснование: не указано Дата исследования: 1 февраля 2025, 06:03
Тип чтения	Первое чтение.
Базовое исследование для сравнения	Дата проведения: 31.01.2025.
Место проведения расшифровки исследования	ГБУЗ "НИИ НДХиТ ДЗМ".

Описание	Состояние после артроскопии левого коленного сустава, удаления свободных и фиксированных к/хр фрагментов патологического очага надколенника с артротомией, иссечения патологической хрящевой ткани, микрофрактурирования и хондропластики JointRep, пластики МПФЛ аутосухожилием m.semitendinosus, медиализации и дистализации бугристости большеберцовой кости, парциального латерального релиза от 24.01.2025 г. На сериях контрольных МР томограмм левого коленного сустава, полученных в 3-х плоскостях, в положении сканирования взаимоотношения в коленном суставе не нарушены, суставные поверхности в целом конгруэнтны. Зоны роста с тенденцией к закрытию. Визуализируется зона отека дистальных отделов бедренной кости, на фоне которого определяется костный канал с фиксирующим винтом, идущий от внутренней поверхности косо вверх. Так же определяется зона отека проксимального метафиза большеберцовой кости, передние отделы его неровные. На краю зоны сканирования определяется артефакт неоднородности магнитного поля от фиксирующих элементов бугристости большеберцовой кости. Сохраняется деформация кортикального слоя передне-боковой поверхности латерального мыщелка бедренной кости. Гиалиновый хрящ остальных отделов суставной поверхности мыщелков бедренной кости и большеберцовой костей значимо не изменен. Форма и положение менисков значимо не изменены, МР сигнал от них не изменен. Задняя и передняя крестообразные, латеральная коллатеральная связки прослеживаются на всем протяжении, стриарность сохранена. Медиальная коллатеральная, латеральная пателло-фemorальная связки и подвздошно-большеберцовый тракт неоднородны, утолщены, с прерыванием части волокон (операционный доступ).Трансплантат медиальной пателло-фemorальной связки прослеживается удовлетворительно. Сухожилие четырехглавой мышцы бедра и собственная связка надколенника так же отечны, траектория их сохранена. В положении сканирования индекс Insall-Salvati около 1,7 (ранее 1,4). Индекс TT-PCL около 20 мм (ранее около 24,0 мм). Надколенник по форме Wiberg III, обычных размеров, не смещен. Трабекулярное вещество его отечно с наличием костного канала в его структуре. Отмечаются послеоперационные изменения суставной поверхности надколенника в виде формирования ложа, заполненного гелием и прикрытого костными фрагментами надколенника. Сохраняется деформация ниже-медиального края надколенника Жировые тела и синовиальная оболочка сустава отечны. В полости сустава умеренное количество выпота. Параартикулярные мягкие ткани неравномерно отечны.
Заключение	МРТ картина состояния после острого вывиха надколенника левого коленного сустава и последующего хирургического лечения (подробно в примечании): послеоперационные изменения суставной поверхности надколенника и бугристости большеберцовой кости; положение трансплантата медиальной пателло-фemorальной связки удовлетворительное; отек параартикулярных мягких тканей; сохраняющаяся деформация передне-наружных отделов латерального мыщелка бедренной кости и ниже-медиального края надколенника; отек жировых тел сустава; умеренный выпот в полости сустава.
Рекомендации	Требуется дообследование: Нет.
Оборудование	Название устройства: MPT Achieva 3.0 T. Вид: MPT. Инвентарный номер: 4003. Серийный номер: 4003. Модель: Achieva 3.0 T.